# 위산약을 오래 먹는데 배가 더부룩해요

**SIBO와 약 재평가** — 위산 분비 억제제(PPI·P-CAB)를 오래 드시면서 배가 더부룩하거나 가스·설사·복통이 이어질 때, 연수강좌 질의응답에서 연자가 답한 내용과 속쓰림 강의의 약 사용 원칙을 함께 정리했습니다.

## 오래 먹는 위산약과 SIBO(소장 내 세균 과증식)

| 장기 사용과 SIBO 위험 | 원인으로 확정되었나요? | P-CAB은 PPI보다 위험이 높은가요? |
|---|---|---|
| **약 2배** | **확정 아님** | **근거 없음** |
| 연관성이 보고되었습니다 | 대부분 관찰 연구입니다 | 현재까지 더 높다고 볼 근거는 없습니다 |

**연수강좌 질의응답 · 연자의 답변**

PPI나 P-CAB을 오래 쓰면 SIBO **위험이 약 2배 늘어나는 연관성**이 있습니다. 다만 대부분 **관찰 연구**여서, 약이 직접 SIBO를 일으킨다고 확정된 것은 아닙니다. P-CAB은 연구가 아직 충분히 쌓이지 않았으며, 지금까지 PPI보다 SIBO 위험이 더 높다고 볼 근거는 없다고 연자는 답했습니다.

**PPI**는 위산을 만드는 펌프를 막는 약(프로톤펌프억제제), **P-CAB**은 같은 펌프를 칼륨 경쟁 방식으로 막는 약(칼륨경쟁적 위산분비억제제)입니다.

## 더부룩함이 이어질 때 — 이렇게 정리합니다

1. **증상이 없다면** 무증상 환자의 SIBO 선별검사는 권장되지 않고, 필요한 위산 억제제를 **일률적으로 끊는 것도 권장되지 않습니다.**
2. **왜 오래 드시는지**(장기 복용 이유, 적응증)를 진료에서 다시 확인합니다.
3. 필요하지 않다면 **줄이거나 끊고**, 필요하다면 **가장 적은 유효 용량(최소 유효용량)**으로 유지합니다.
4. 복부 팽만·가스·설사·복통이 **계속된다면** 수소호기검사(숨으로 내쉰 수소 가스를 재는 검사)를 고려합니다.

## 약은 센 약부터 시작해 차차 내려옵니다 (step-down)



센 약부터 → 차차 줄여 내려오기

**식도염과 단순 속쓰림은 약 선택이 다릅니다**

**식도염** — PPI보다 **P-CAB이 더 유용**합니다. 식도염 치료는 가장 효과적인 약부터 시작한 뒤 **차차 내려오는 step-down**이 원칙이고, PPI는 치료에 한계가 있기 때문입니다.

**단순 속쓰림 증상** — 위염 적응증이 있는 **H2RA(히스타민 수용체 차단제)**, **1/4 용량 PPI(quarter dose)**, 또는 P-CAB이 좋은 치료약이 될 수 있습니다.

**내려온 뒤 다시 재발하면** — 충분한 기간 치료 후 중단했을 때 다시 재발하는 경우가 있어 **유지치료**(지속 복용 또는 필요시 복용)를 고려하며, 재발 정도에 맞춰 사용한다고 연자는 답했습니다.

## 위산약은 모든 증상에 똑같이 듣지는 않습니다

| 가슴쓰림·식도염 | 가슴 통증·만성 기침 | 쉰 목소리·후두염·천식 |
|---|---|---|
| 전형적인 가슴쓰림과 식도염을 낫게 하는 데 PPI가 매우 효과적이라고 연자는 설명했습니다. | 역류 증상이 함께 있는 경우에 효과가 좋았다고 설명했습니다. | 후두 증상이나 잘 조절되지 않는 천식은 PPI로 좋아지는 경우가 아주 드물었다고 설명했습니다. |

### 진료 때 이렇게 말씀해 주세요 — 약은 임의로 끊지 않습니다

- 위산약(PPI·P-CAB)을 **언제부터, 어떤 이유로** 드셨는지, 지금도 **꼭 필요한지**
- 더부룩함·가스·설사·복통이 **계속되는지**, 식후에 심한지 가슴쓰림이 중심인지
- 클로피도그렐 같은 **함께 드시는 약**이 있는지 — 약은 임의로 끊지 말고 진료에서 줄이는 방법을 정합니다

**광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine**

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

**출처** · 아산 28회 연수강좌 — 속쓰림 환자의 진단과 치료(김도훈)

*본 자료는 일반 안내입니다. 위산 억제제는 임의로 끊거나 용량을 바꾸지 마시고, 복용 이유와 증상을 진료에서 상의해 주세요.*

# 약 재평가 — 기간·원인·약 비교

오래 드시는 위산약은 목적과 기간을 정해 두고, 더부룩함의 중심이 무엇인지에 따라 약을 고릅니다.

## 얼마나, 어떻게 이어가나요 — 2025 서울 합의안(강의 소개)

| 역류질환의 상태 | 처음 치료 | 오래 이어갈 때(유지치료) |
|---|---|---|
| **미란이 없는 역류질환(NERD) 또는 가벼운 미란성 식도염** | 하루 1회 **표준용량 PPI 또는 P-CAB, 4~8주** | 필요할 때만 복용하는 **on-demand** PPI 또는 P-CAB |
| **심한 미란성 식도염** | **표준용량 P-CAB 또는 PPI, 8주**(하루 1회) | 매일 계속 복용하는 **continuous** P-CAB 또는 PPI |
| **오래 유지해야 하는 경우** | 증상을 조절하고 점막 치유를 유지하는 **가장 낮은 유효 용량**을 씁니다 — 과다 사용과 잠재적 위험을 피하기 위해서입니다. | |

## 더부룩함이 꼭 SIBO는 아닙니다 — 증상 중심에 따라 약이 다릅니다

### 식후 더부룩함·빨리 배부름이 중심일 때

- 식후 **2시간 이내** 가득 찬 느낌이나 일찍 배가 부른 느낌이 중심이면 기능성 소화불량증 중 **식후 불편 증후군(PDS)**으로 봅니다.
- 이때는 **PPI보다 위장관 운동 촉진제(prokinetics)를 먼저** 쓰는 것이 맞다고 강의에서 설명했습니다.
- 명치 통증·쓰림이 중심이면 **명치 통증 증후군(EPS)**으로 보고 PPI를 먼저 쓰며 운동 촉진제를 함께 쓸 수 있습니다.
- 한국 기능성 소화불량증 진료지침은 **40세 이상이거나 경고 증상**이 있으면 약보다 **내시경을 먼저** 하도록 안내합니다.

### 가슴쓰림(HEARTBURN)이 중심일 때

- 전형적인 가슴쓰림·신물 역류는 **표준용량 PPI를 2주** 써 보아 듣는지 봅니다(PPI test). 듣지 않으면 24시간 산도검사를 제안합니다.
- 그래도 낫지 않으면 위산이 아니라 식도·위장이 **예민한 상태**(내장 과민성) 쪽 치료로 넘어갑니다.

## 약이 잘 듣지 않거나 약을 바꿀 때 참고

| 비교 항목 | PPI | P-CAB |
|---|---|---|
| **약이 작용하는 방식** | 위산을 만나 활성형으로 바뀐 뒤 작용합니다(전구약물). 안정적인 효과까지 **3~5일**이 걸립니다. | 바로 작용하는 약이라 **첫 복용 1시간 이내** 효과가 나타납니다. |
| **복용 시점** | **식사 30분~1시간 전**에 먹어야 활성화된 펌프를 가장 많이 막습니다. | 식사와 상관없이 위산 억제 효과가 있습니다. |
| **하루 중 위 안 산도 pH 4 이상 유지 시간** | 평균 **49.6%** | 평균 **77.1%** (식도염 치유 기준선 75%) |
| **사람마다·약마다 차이** | PPI를 빨리 분해하는 체질(CYP2C19 extensive metabolizer)이 아시아인에서 **26~47%**입니다. 혈소판 약 **클로피도그렐**과 같은 효소를 써서 서로 영향을 줄 수 있습니다. | 다른 효소(CYP3A4)로 분해되어 클로피도그렐과 대사 경로가 겹치지 않습니다. |

약이 잘 듣지 않는다며 내원한 216명을 24시간 산도검사로 본 결과 **진짜 위산 때문인 경우는 약 7분의 1**이었고 나머지는 식도 예민성과 관련되어, 약만 늘리기보다 원인을 다시 따져 보는 것이 중요하다고 연자는 설명했습니다.

## 위산약만으로 부족할 때 — 다음 선택지

### 역류 자체를 겨냥하는 치료

- **바클로펜** — PPI에 반응이 낮을 때 더해 쓰며, 트림이 많거나 서 있을 때 역류하는 분, 비만한 분에게 도움이 될 수 있습니다. 장기 사용 시 부작용이 두드러져 **단독 사용은 권하지 않고**, 낮은 용량에서 시작해 천천히 올립니다.
- **알긴산 제제** — 위 내용물 위에 뜨는 겔 층이나 점막을 덮는 막으로 역류를 막아 줍니다.
- 그래도 낫지 않으면 **내시경 치료** 방법이 있습니다.

### '항우울제'가 아닌 '신경조절제'

- 연자는 우울하거나 불안해서 쓰는 약이 아니라, 장과 뇌의 신호 교류로 **위장관이 예민해진 상태**를 치료하는 데 낮은 용량의 항우울제가 효과가 있어 쓰는 것이라고 환자에게 설명한다고 답했습니다.
- 그래서 이런 약을 **신경조절제**라고 부르며, 약국에서 항우울제라는 설명을 듣더라도 오해하지 않으셔도 됩니다.
- 목에 뭔가 걸린 느낌(globus)은 가슴쓰림이 함께 있으면 치료가 잘 되는 것으로 알려져 있고, 신경조절제까지 써도 계속되면 **이비인후과 진료**를 권한다고 답했습니다.

**광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine**

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

**출처** · 아산 28회 연수강좌 — 속쓰림 환자의 진단과 치료(김도훈)

*본 자료는 일반 안내입니다. 위산 억제제는 임의로 끊거나 용량을 바꾸지 마시고, 복용 이유와 증상을 진료에서 상의해 주세요.*

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/gi/asl28-ppi-bloating-sibo/